HÔPITAUX Paris

Saint Joseph — Marie Lannelongue

LIVRET D'ACCUEIL

TOME 3

MON INTEGRATION



SERVICE DES URGENCES

SOMMAIRE

1. Organisation de mon integration 3
Votre parcours d'intégration 3
Planning d'integration 3
Premier jour 5
Journée 8ème jour 6
Journée : Doublon à 1 mois 6
2. L'integration 7
Les 10 compétences IDE 7
Compétence clinique 8
Compétence théorique 8
Prise en charge globale du patient 9
Gestion des priorités et des flux 10
Compétence relationnelle et communication 11
Sécurité et qualité des soins 12
Connaissance et formation continue 14
Posture professionnelle 15
Gestion et contrôle de l'environnement de soins 16
Gestion documentaire et réglementaire 18
A maitriser à la fin de son integration 19
A decouvrir dans chaque zones 21
Zone valide (Zone 1) 21
Zone couchée (zone 2) 22
Salle d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV) 23
Les lits d'urgences (LP) 24
3. Tableau d'auto-évaluation 26

1. ORGANISATION DE MON INTEGRATION

VOTRE PARCOURS D'INTEGRATION

En amont de son intégration, l'infirmier a rencontré le cadre pour une première prise de contact et pour prendre connaissance de son planning prévisionnel.

Dans un second temps, les infirmiers référents enverront un courrier électronique au nouvel arrivant, afin de lui apporter les informations nécessaires à sa prise de poste, son planning d'intégration (comprenant la zone et le prénom de l'infirmier qui sera charger de les intégrer), mais aussi les 8 tomes du livret d'accueil.

PLANNING D'INTEGRATION

Le planning d'intégration se présentera sous la forme suivante :

PRENOM, NOM								
Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date
Zone des urgences	Zone des urgences	Zone des urgences	Zone des urgences	Zone des urgences	Zone des urgences	Zone des urgences	8ème journée d'intégration	Journée de doublon – 1 mois
Prénom IDE encadrant	**Prénom IDE encadrant**	**Prénom IDE encadrant**	**Prénom IDE encadrant**	**Prénom IDE encadrant**	**Prénom IDE encadrant**	**Prénom IDE encadrant**	**Prénom IDE Référent ou Formateur**	**Prénom IDE Référent ou Formateur**
Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée	Horaire de la journée

Vous y retrouverez, la date de vos jours d'intégration, la zone dans laquelle vous serez intégré, l'IDE qui aura pour rôle de vous doubler et de vous accompagner tout au long de votre journée et pour terminer vos horaires de la journée.

L'ordre des zones est aléatoire, ce qui est sûre c'est que le nouvel infirmier pendant son intégration réalisera :

- 2 journées en zone 1 (zone valide).

- 2 journées en zone 2 (zone couchée).
- 2 journées aux lits d'urgences (service d'hospitalisation).
- 1 journée à la SAUV (Salle d'Accueil des Urgences Vitales).

PREMIER JOUR

Lors de votre premier jour, vous serez accueilli dans le service par l'un des infirmiers référents de jour (Me OURBAA et/ou Mr SILVETTI) ou le cas échéant, par une des cadres du service ou un infirmier de l'équipe.

Dans un premier temps, nous aurons le plaisir de vous présenter l'hôpital. Cette visite doit permettre au nouveau collaborateur de prendre connaissance de la localisation des différents services de soins ou technique.

Nous vous présenterons :

- La cité hospitalière (L. BELLAN ; l'AURA ; ARAGO ; ...).
- La pharmacie (porte 16, niveau -1).
- Le laboratoire / EFS.
- La réanimation (porte 10).
- Le plateau technique interventionnel (PTI).
- La salle de soins poste interventionnel (SSPI).
- Le plateau d'imagerie (radiologie, scanner, IRM).
- La lingerie
- L'unité de soins intensif de cardiologie = USIC (porte 4, niveau 2).
- L'unité de soins intensif neuro-vasculaire = USINV (porte 14, niveau 1).
- Le PC sécurité.
- La caisse centrale.
- Le self.

Lors de cette première journée, nous vous accompagnerons dans la création de votre badge professionnel.

Puis dans un second temps, nous contacterons la lingerie, afin de pouvoir synchroniser votre badge et obtenir vos crédits de tenues professionnelles.

La visite du service ayant déjà été faite auparavant (lors de votre entretien), elle ne sera pas refaite lors de votre première journée.

Par la suite, l'infirmier référent nous vous présenterons les différents logiciels métiers, tout en vous communiquant vos codes informatiques, et en les testant :

- Windows – permettant d'accéder à votre boîte mail professionnelle par la suite.
- DxCare
- Pharma

- Théo
- Paramedic
- Intranet et espace métier spécifique aux urgences.
- Ennov'

Pour terminer, nous vous accompagnerons à votre vestiaire. Puis vous débuterez votre journée au sein de l'équipe soignante pour la suite de la journée.

JOURNEE 8EME JOUR

Dans le prolongement de notre parcours d'intégration, nous avons mis en place une journée dédiée, intitulée le 8e jour d'intégration. Cette journée particulière permet au nouveau professionnel d'être en doublure avec l'infirmier(ère) formateur(trice) ou l'IDE référent(e) du service. Elle constitue un temps d'échange privilégié pour faire un point sur son intégration, identifier d'éventuelles difficultés et approfondir certains aspects essentiels au bon fonctionnement du service.

Ce moment permet également de transmettre des savoirs organisationnels, relationnels et techniques propres aux urgences, en s'appuyant sur l'expertise et l'expérience de l'IDE encadrant. Le 8e jour d'intégration s'inscrit ainsi comme un véritable levier de professionnalisation et de sécurisation des pratiques.

JOURNEE : DOUBLON A 1 MOIS

Afin d'assurer un suivi régulier et adapté de l'intégration, un doublon est également prévu un mois après l'arrivée du nouveau professionnel. Cette journée permet de faire un point d'étape sur son appropriation des procédures et des protocoles en vigueur dans le service. Elle vise également à évaluer sa compréhension de l'organisation générale et sa capacité à s'y inscrire efficacement.

Ce temps d'observation et d'échange permet d'identifier les éventuels besoins complémentaires en formation ou en accompagnement, tout en vérifiant que le professionnel est opérationnel pour exercer en autonomie au sein des urgences.

2. L'INTEGRATION

LES 10 COMPETENCES IDE

Dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue, nous avons élaboré dix compétences spécifiques à l'exercice infirmier en service d'urgences. Ces compétences ont pour objectif de mettre en lumière les attentes professionnelles essentielles dans ce contexte exigeant et spécifique.

Chacune d'elles est accompagnée d'un critère d'évaluation précis, permettant de guider le développement des infirmiers et d'assurer un haut niveau de qualité et de sécurité des soins. Afin de garantir l'acquisition et la maîtrise de ces compétences, nous mobilisons différents moyens pédagogiques, notamment des journées de doublure encadrées et des formations ciblées.

Cette démarche vise à structurer l'intégration des professionnels et à renforcer leur autonomie et leur efficacité au sein du service.

- Compétence clinique
- Compétence théorique
- Prise en charge globale du patient
- Gestion des priorités et des flux
- Compétence relationnelle et communication
- Sécurité et qualité des soins
- Connaissance et formation continue
- Posture professionnelle
- Gestion et contrôle de l'environnement de soins
- Gestion documentaire et réglementaire



COMPETENCE CLINIQUE

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Évaluation rapide et fiable du patient	Être capable d'évaluer un patient en moins de 5 minutes pour identifier les risques vitaux	À 1 mois
Priorisation des soins	Savoir prioriser les soins selon la gravité et l'urgence des patients	À 1 mois
Reconnaissance des urgences vitales	Identifier immédiatement les situations à risque vital (détresse respiratoire, choc, AVC, SCA, etc.)	À 6 mois
Capacité à utiliser les outils d'évaluation standardisés	Utilise à bon escient les outils, échelles : Glasgow, Cushmann, EN, EVS, …	À la fin de l'intégration

COMPETENCE THEORIQUE

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Pose et surveillance de voie veineuse périphérique	Poser une VVP adaptée, sécurisée et surveillée selon protocole	À la fin de l'intégration
Réalisation d'un ECG (12, 18, D2 long)	Réaliser un ECG complet et de qualité,	À la fin de l'intégration
Administration de thérapeutique selon la règle des 5B	Administrer tout médicament en respectant les 5B (Bon patient, Bon médicament, Bonne dose, Bonne voie, Bon moment)	À la fin de l'intégration
Utilisation de dispositifs médicaux : Scope, tensiomètre, PSE, PCA, ..	Savoir utiliser et régler correctement chaque dispositif	À 1 mois

Prélèvement sanguin veineux, artérielle	Réaliser des prélèvements en respectant l'asepsie et les procédures spécifiques	À la fin de l'intégration
Participation à l'intubation (plateau, préparation des thérapeutiques, ...)	Préparer l'intubation : matériels, médicaments, sécurisation du patient	À 6 mois
Participation à une réanimation (positionnement, préparation des thérapeutiques, massage, ...)	Participer activement à une réanimation : massage efficace, médications, coordination	À 6 mois
Connaissance et utilisation des matériels spécifiques (chariot d'urgence, KTA, KTC, Drain Thoracique, KT Intra-Osseux, ...)	Connaître, préparer et utiliser les matériels spécifiques d'urgence	À 6 mois

PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Surveillance continue et adaptée	Adapter la surveillance en fonction de la pathologie, du risque et des protocoles (signes vitaux scope...)	À la fin de l'intégration
Anticipation des complication	Identifier les risques potentiels selon le diagnostic et anticiper les complications	À 1 mois
Sécurité du patient	Appliquer systématiquement les règles de sécurité (barrières, surveillance, identitovigilance, transmissions)	À la fin de l'intégration
Préparation pour des examens complémentaire	Préparer le patient (jeûne, information, protocole), anticiper les besoins spécifiques	À la fin de l'intégration

Prise en charge de la douleur (évaluation, outils, ...)	Savoir évaluer, tracer et traiter la douleur selon les outils adaptés (EVA, EN, Doloplus)	À la fin de l'intégration
Adaptation de la prise en charge au contexte (pédiatrie, gériatrie, psychiatrie)	Adapter les soins aux spécificités de l'âge ou du contexte psy : communication, gestes, évaluation	À 1 mois
Préparation à la sortie, retour à domicile, transfert, ...	Anticiper la sortie, s'assurer de la continuité des soins et du bon transfert d'information	À la fin de l'intégration
Patient propre et moyen d'éliminer en lien avec son autonomie	Assurer une hygiène adaptée, respecter l'autonomie du patient, proposer les moyens nécessaires (bassin, sonde, changes)	À la fin de l'intégration

GESTION DES PRIORITES ET DES FLUX

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Optimisation du circuit patient	Assurer un flux fluide du patient dans le service : triage, soins, examens, sorties, transferts	À 6 mois
Gestion simultanée de plusieurs situations	Être capable de prioriser et répartir les soins en gérant plusieurs patients avec des degrés d'urgence différents	À 1 mois
Coordination des soins et des intervenants	Assurer la coordination entre médecins, aides-soignants, brancardiers, radiologues, spécialistes	À 1 mois
Connaissance et application des règles concernant l'installation	Installer les patients selon les recommandations : confort, sécurité, respect de la pathologie et du matériel	À la fin de l'intégration

COMPETENCE RELATIONNELLE ET COMMUNICATION

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Travail en équipe : écoute, adaptation, respect des rôles	Collaborer efficacement avec tous les membres de l'équipe, en respectant les rôles et en s'adaptant aux situations	À la fin de l'intégration
Communication avec le patient	Communiquer de façon claire, rassurante et adaptée au patient, en expliquant les soins et la situation	À la fin de l'intégration
Communication avec la famille	Être capable d'expliquer la situation au proche avec empathie et clarté	À la fin de l'intégration
Communication avec l'équipe	Communiquer efficacement en équipe : partage d'informations, demandes claires, coordination	À la fin de l'intégration
Communication avec le réseaux extérieurs (brancardiers, pompiers, service, ...)	Savoir transmettre les informations essentielles et orienter les acteurs extérieurs efficacement	À la fin de l'intégration
Qualité des transmissions orales et écrites	Transmettre des informations fiables, pertinentes et traçables (oralement et par écrit)	À la fin de l'intégration
Capacité à informer et orienter	Informer le patient ou l'équipe sur la suite de la prise en charge, l'orientation ou les démarches à suivre	À 1 mois
Gestion des conflits ou tensions	Gérer les tensions interpersonnelles (patients, famille, équipe) en maintenant un climat professionnel	À la fin de l'intégration

SECURITE ET QUALITE DES SOINS

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Respect strict des règles d'hygiène et prévention des infections	Appliquer rigoureusement les procédures d'hygiène pour limiter le risque infectieux	À la fin de l'intégration
Respect des précautions standard (tenue propre, chaveux attaché, ongles courts, pas de bijoux, manche courtes, ...)	Tenue irréprochable selon les règles en vigueur pour limiter les risques	À la fin de l'intégration
Utilisation des EPI	Porter les EPI adaptés à chaque situation clinique pour se protéger et protéger le patient	À la fin de l'intégration
Connaissance des différentes précautions complémentaires	Maîtriser les différentes précautions spécifiques selon la pathologie infectieuse	
Application des règles d'identitovigilance	Assurer l'identification correcte du patient à chaque étape du soin	À la fin de l'intégration
Participation à la déclaration des événements indésirables	Savoir repérer, tracer et déclarer tout événement indésirable ou risque identifié	À 1 mois
Connaissance des procédure, sortie à l'insu du service, fugue	Maîtriser les conduites à tenir en cas de fugue ou d'incident de sécurité	À 1 mois
Vigilance sur les risques environnementaux et matériels	Être capable de repérer et signaler les défaillances matérielles ou environnementales (panne, danger, hygiène)	À la fin de l'intégration

Connaissance des plans d'urgence : AMAVI, NRBC, Cyberattaque	Connaître les grands plans de sécurité et savoir les appliquer	À 6 mois

CONNAISSANCE ET FORMATION CONTINUE

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Mise à jour régulière des connaissances médicales et infirmières	Maintenir et actualiser ses connaissances professionnelles	À la fin de l'intégration
Connaissance des recommandations HAS, SFAR, SFMU	Connaître et appliquer les recommandations officielles actualisées	À la fin de l'intégration
Investissement dans la formation des nouveaux agents	Accompagner activement les nouveaux arrivants et transmettre les pratiques	À 6 mois
Investissement dans la formation des étudiants	Accompagner activement les étudiants et transmettre les pratiques	À 6 mois
Tutorat des étudiants paramédicaux	Encadrer et transmettre les savoirs aux étudiants paramédicaux en stage, en tant que tuteur de stage	À 1 an
Participation et présence aux formations institutionnelles obligatoire (incendie, hémovigilance, RGPD)	Être présent aux formations obligatoires ou proposées par l'établissement	À la fin de l'intégration
Participation et présence aux cours du service	Participer activement aux cours internes réguliers	À la fin de l'intégration
Participation et présence aux formations internes aux services	Assister aux formations proposées spécifiquement par le service	À la fin de l'intégration

Réalisation des formations accessible du Campus Santé	Réalisation en e-learning des formations obligatoires ou proposées par l'établissement	À la fin de l'intégration
Participation à des PIMS	Suivre les programmes institutionnels de maintien des compétences	À 1 an
Participation à des débriefings / analyses de pratiques / RMM / CREX	Participer activement aux démarches qualité et aux retours d'expériences	À 1 an

POSTURE PROFESSIONNELLE

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Gestion du stress et maîtrise émotionnelle	Adapter ses réactions émotionnelles et son comportement face aux situations de stress, sans altérer la qualité des soins	À la fin de l'intégration
Autonomie dans la prise de décision selon le cadre réglementaire	Prendre des décisions adaptées en respectant le cadre légal et les protocoles du service	À 1 mois
Esprit d'initiative et de proposition	Proposer des améliorations, anticiper les besoins et s'impliquer activement dans la dynamique du service	À 6 mois, 1 an
Ethique et respect du secret professionnel	Respecter la confidentialité des informations patients et appliquer les principes déontologiques	À la fin de l'intégration
Attitude bienveillante et empathique	Adopter une posture respectueuse et empathique envers les patients, familles et collègues	À la fin de l'intégration

GESTION ET CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT DE SOINS

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Contrôle régulier de la zone de soins : propreté, rangement, sécurité	Maintenir une zone de soins propre, rangée et sécurisée pour garantir la sécurité des patients et du personnel	À la fin de l'intégration
Vérification et gestion des stocks de matériel	Assurer un stock suffisant et organisé pour éviter les ruptures et faciliter l'accès	À la fin de l'intégration
Contrôle quotidien et rigoureux des stupéfiants	Garantir la sécurité et la traçabilité des stupéfiants conformément à la réglementation	À la fin de l'intégration
Participation active à la matériovigilance (déclaration d'incident matériel	Identifier et déclarer rapidement tout incident ou dysfonctionnement lié au matériel	À la fin de l'intégration
Participation à la pharmacovigilance (signalement des effets indésirables médicamenteux, erreurs médicamenteuses)	Signaler tout effet indésirable ou erreur médicamenteuse pour améliorer la sécurité	À la fin de l'intégration
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs médicaux (défibrillateur, ventilateur, pousse-seringue, etc.)	Assurer la disponibilité et le bon état de fonctionnement des dispositifs médicaux essentiels	À la fin de l'intégration
Anticipation des ruptures de stock ou dysfonctionnements	Identifier en amont les risques de rupture ou panne et agir pour les prévenir	À la fin de l'intégration

GESTION DOCUMENTAIRE ET REGLEMENTAIRE

Critère évalué	Objectif	Niveau attendu à
Conformité dans la tenue des registres (stupéfiants, coffre, vestiaire…)	Garantir une traçabilité rigoureuse et conforme aux exigences réglementaires	À la fin de l'intégration
Connaissance des procédures locales de signalement (pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance)	Maîtriser les circuits de signalement des événements indésirables selon les procédures en vigueur	À 1 mois
Connaissance des procédures locales : retour pharmacie, température frigo, stupéfiant nominatif, CGR, …	Respecter les procédures spécifiques liées à la gestion des produits et matériels hospitaliers	À 1 mois
Capacité à rédiger une fiche d'évènement indésirable	Savoir rédiger de façon claire, précise et complète une fiche d'évènement indésirable	À 1 mois

A MAITRISER A LA FIN DE SON INTEGRATION

À l'issue de la période d'intégration, le professionnel doit avoir la capacité d'assurer de manière autonome l'ensemble des gestes, procédures et savoirs essentiels au bon fonctionnement du service des urgences dans sa globalité, y compris les lits d'urgences.

Les points suivants doivent avoir été abordés, compris et intégrés :

1. <u>Outils informatiques et traçabilité</u>
   - ☐ **DxCare** :
     - ☐ Suivi des bilans,
     - ☐ Accès aux comptes rendus SAU,
     - ☐ Pancarte,
     - ☐ Plan de soins,
     - ☐ Transmissions
   - ☐ **Cardiolex** : réalisation et lecture d'ECG.
   - ☐ **ID Now** : utilisation pour tests Covid, grippe.
   - ☐ **Traçabilité des médicaments** :
     - ☐ Vérification des tiroirs le week-end,
     - ☐ Retours pharmacie,
     - ☐ Stupéfiants
     - ☐ Médicaments spécifiques (Octaplex, Actilyse, ...).
   - ☐ **Traçabilité des appareils à glycémie**.
   - ☐ **Rédaction des transmissions** patients et participation aux transmissions orales.
2. <u>Soins techniques et matériel médical</u>
   - ☐ Utilisation du **pneumatique** pour l'envoi des bilans.
   - ☐ Utilisation du **bladder scan** et des batteries.
   - ☐ Utilisation des **packs de froid**.
   - ☐ Utilisation du **Méopa** (localisation, désinfection de la valve, <u>ne pas jeter la valve</u>).
   - ☐ Utilisation et gestion du **sac à dos d'urgence**.
   - ☐ Connaissance et localisation du **chariot de kits**.
   - ☐ Connaissance et localisation du **chariot d'urgence adulte et pédiatrique.**
   - ☐ Connaissance et localisation de **l'armoire KTA/KTC.**
   - ☐ Connaissance et localisation de **l'armoire Drain Thoracique.**

- ☐ Connaissance et localisation du **KT intra-osseux.**
- ☐ Utilisation du **réfrigérateur** (frigo à médicaments ou produits biologiques).
- ☐ Localisation des **obus à O2**.
- ☐ Localisation et utilisation des **laves-bassins** et de la **machine à glace**.

3. <u>Prélèvements et prescriptions biologiques</u>

- ☐ Connaissance des tubes de prélèvements :
  - ☐ Ordre de prélèvement,
  - ☐ Étiquetage,
  - ☐ Bons de thrombolyse
  - ☐ Bons de groupe sanguin.
- ☐ Bons de prescription en cas de prescription non connectée
- ☐ Utilisation de la prescription connectée.
- ☐ Préparation des pochettes d'envoi.
  - ☐ Connaissance de la signification des couleurs des pochettes.
  - ☐ Récupération des pochettes auprès du laboratoire.
- ☐ Utilisation du ID Now pour les tests Covid et grippe.

4. <u>Procédures médicales et institutionnelles</u>

- ☐ **Observation IOA** : motif, tri couleur, paramètres vitaux, douleur, personne à prévenir.
- ☐ **Protocoles de coopération professionnelle** : isolements, colique néphrétique, asthme,
- ☐ **Procédures d'isolement** : BMR, BHRe, Ébola, Covid.
- ☐ **Procédures spécifiques** :
  - ☐ Procédure **chute**.
  - ☐ Procédure **décès**.
  - ☐ Procédure **fugue/sortie à l'insu du service.**
- ☐ **Plan spécifique** :
  - ☐ **AMAVI**.
  - ☐ **NRBC**.
  - ☐ **Cyberattaque**
- ☐ **Gestion du matériel défectueux** : identification et signalement via IDE référente.
- ☐ **Réassort** des différentes zones de soins, chariot de suture et box plâtre

5. <u>Sécurité et alertes</u>

- ☐ **Alarme agression** : localisation, fonctionnement.
- ☐ **Alarme ACR** : procédure à suivre en cas d'arrêt cardio-respiratoire.
- ☐ **Règles** concernant la présence des **accompagnants** (Charte + Badge)

A DECOUVRIR DANS CHAQUE ZONES

Pendant votre intégration, vous effectuerez des journées dans chaque zone du service (mise à part à l'accueil). Chaque zone possède ces spécificités, il est donc demandé à l'infirmier de prendre connaissance de ces spécificités pendant son intégration. Nous considérons qu'à la fin de son intégration, l'infirmier connaît et maîtrise ses spécificités.

Dans le cas où vous n'avez pas eu le temps de prendre connaissance de l'une des spécificités, retournez-vous rapidement vers l'équipe d'encadrement (notamment, les IDE référents du service).

Afin d'y voir plus claire, nous les avons classés par zones :

ZONE VALIDE (ZONE 1)

1. **Connaissance de l'environnement et organisation de la zone 1**
   - ☐ Visite de la zone 1 :
     - ☐ Box IDE,
     - ☐ Box médecin
     - ☐ Box plâtre
     - ☐ Chariot de sutures
   - ☐ Présentation de l'organisation en zone 1 :
     - ☐ Gestion des bannettes de soins,
     - ☐ Fonctionnement du circuit court,
     - ☐ Utilisation de la checklist,
   - ☐ Connaissance des numéros utiles.
   - ☐ Rôle de l'AMA circulante.
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ Prise de rendez-vous sur DxPlanning :
     - ☐ Orthopédie,

- ☐ Digestif,
- ☐ Médecine vasculaire,
- ☐ Pneumologie,
- ☐ Imagerie (scanner),

3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**
   - ☐ Accès aux armoires de matériel orthopédique et mise en place des attelles.
   - ☐ Traçabilité du matériel orthopédique via Orthoserv.
   - ☐ Prise en charge de la syndactylie (contention, immobilisation).
4. **Soins techniques et sécurité**
   - ☐ Réalisation des vaccinations et remplissage des documents de traçabilité.
   - ☐ Connaissance de la procédure des AES (accidents d'exposition au sang) et bons de laboratoire.
5. **Prise en charge infirmière globale**

ZONE COUCHEE (ZONE 2)

1. **Connaissance de l'environnement et organisation de la zone 2**
   - ☐ Visite de la zone 2 :
     - ☐ Box,
     - ☐ Espace d'attente
   - ☐ Présentation de l'organisation en zone 2 :
     - ☐ Gestion des bannettes de soins,
     - ☐ Fonctionnement et organisation zone 2A, zone 2B
     - ☐ Utilisation de la checklist,
   - ☐ Connaissance des numéros utiles.
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ « Check patient » pour tout examen et/ou transfert.
3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**
   - ☐ Moniteur de surveillance
     - ☐ Scope,

- ☐ Dynamap,
- ☐ Débitmètre : oxygène, air et d'aspiration,

4. **Soins techniques et sécurité**
   - ☐ Protocole de titration en morphine.
5. **Prise en charge infirmière globale**
   - ☐ Prise en charge du patient en zone couchée.
   - ☐ **Flyers « Lits d'urgences »** à remettre aux accompagnants pour chaque patient hospitalisé aux lits d'urgences.
6. **Environnement spécifique**
   - ☐ Respirateur,
   - ☐ Chariot d'urgences,
   - ☐ Défibrillateur,
   - ☐ Moniteur de surveillance,
   - ☐ Pousse seringue électrique,
   - ☐ Débitmètre : oxygène, air et d'aspiration,
   - ☐ Checklists.

SALLE D'ACCUEIL DES URGENCES VITALES (SAUV)

1. **Connaissance de l'environnement et organisation de la SAUV**
   - ☐ Visite de la SAUV
   - ☐ Présentation de l'organisation en SAUV
     - ☐ Checklist de la SAUV
   - ☐ Frigo : rangement, traçabilité, vérification des médicaments.
   - ☐ Présentation de la centrale des scopes et réglages des alarmes.
   - ☐ Connaissance des numéros utiles.
2. **Planification des soins et coordination médicale**
   - ☐ Prise en charge de patient en trinôme avec le médecin et l'aide-soignant
   - ☐ En fonction de l'activité, prise en charge des patients en zone 2.
3. **Matériel spécifique et dispositifs médicaux**

- ☐ Utilisation du scope, câblage 5 brins, capnographie, douchette (entrée/sortie patient).
- ☐ Présentation des armoires de déchocage (cathéters centraux, drains thoraciques…) et de leur vérification.
- ☐ Localisation, contenu et vérification des chariots d'urgence adulte et pédiatrique.
- ☐ Présentation du sac à dos d'urgences :
  - ☐ Traçabilité,
  - ☐ Procédure d'utilisation (appel, accompagnement en examen ou transfert),
  - ☐ Contenu et vérification.
- ☐ Présentation du DSA et de son utilisation.
- ☐ Présentation du vidéolaryngoscope, chargeur et lames.
- ☐ Connaissance du Médi-Mémo SAUV.

4. Soins techniques et sécurité

- ☐ Utilisation du respirateur :
  - ☐ Vérification,
  - ☐ Montage,
  - ☐ Traçabilité des tuyaux,
  - ☐ Utilisation en VNI.
- ☐ Utilisation du défibrillateur et de sa vérification (manuelle et auto).

5. Prise en charge infirmière globale

- ☐ Participation active à la prise en charge des patients
- ☐ Adaptation aux urgences vitales en environnement instable (SAUV).
- ☐ Protocoles de réanimation et d'urgence

LES LITS D'URGENCES (LP)

1. Connaissance de l'environnement et organisation des lits d'urgences

- ☐ Visite approfondie du service.
- ☐ Présentation des vérifications de début de journée à 7h30 :
  - ☐ Réfrigérateur,
  - ☐ Chariot d'urgence,
  - ☐ Défibrillateur.
- ☐ Présence aux staffs (8h30 et 14h30).
- ☐ Appel des agents administratifs (transferts informatiques, vérification de sortie…).

2. Planification des soins et coordination médicale

- ☐ Coordination avec les services
- ☐ Coordination avec les urgences
- ☐ Préparation des dossiers

3. Matériel spécifique et dispositifs médicaux

- ☐ Procédure d'inventaire des effets personnels.
- ☐ Vérification d'un dépôt au coffre (urgences ou lits d'urgences), vestiaire (-1).
- ☐ Procédure d'impression des examens : scanners, radios…

4. Soins techniques et sécurité

- ☐ Recueil de données et évaluation du degré d'autonomie du patient.
- ☐ Procédure de dépôt au coffre et sécurisation des biens.

5. Prise en charge infirmière globale

- ☐ Prise en charge des patients en binôme avec l'IDE
- ☐ **Flyers « Lits d'urgences »** à remettre aux accompagnants pour chaque patient hospitalisé aux lits d'urgences.
- ☐ Suivi de la checklist "entrée patient" et "sortie/transfert patient".

Checklist – Entrée d'un patient									
Identité patient	Isolement	Conclusion médicale	Antalgique SB prescrit	Traitement habituel prescrit	Recueil de données	Inventaire et coffre	Paramètres vitaux	Pilulier	Optisoins

Checklist – Sortie d'un patient									
Identité patient	Isolement	Conclusion médicale	Imagerie	ECG	Fiche de liaison	Inventaire et coffre	Paramètres vitaux - Impression	Théo - Ambulance	Bulletin de situation

3. TABLEAU D'AUTO-EVALUATION

Ce tableau est un outil de positionnement personnel.

Il a pour objectif de t'aider à faire le point sur tes connaissances, tes compétences et ton niveau de confiance sur les différentes missions que tu seras amené(e) à réaliser en tant qu'**IDE aux urgences**.

Il ne s'agit **ni d'un examen**, ni d'un jugement : ce tableau est là pour **t'orienter, mettre en lumière tes acquis** et **identifier les axes d'apprentissage ou de perfectionnement**.

Cela te permettra également, avec l'équipe encadrante, de construire un **parcours d'intégration et de formation adapté**, afin que tu puisses acquérir progressivement **l'autonomie attendue** dans ce service.

Comment remplir le tableau ?

- Pour chaque compétence ou activité listée, positionne-toi **honnêtement** selon les colonnes proposées.
- Tu peux également indiquer si tu souhaites un accompagnement ou une formation complémentaire sur un point précis.
- Prends le temps de réfléchir à ton expérience passée : certaines compétences peuvent être transversales à d'autres services ou formations

NURSING – MOBILISATION – INSTALLATION DES PATIENTS					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Toilette complète au lit					
Prévention d'escarre / soins de nursing					
Installation et utilisation des tapis de chute.					

ETAT CLINIQUE DU PATIENT					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Surveillance marbrures, myoclonies, cyanose					
Surveillance aspect téguments					
Frissons, sueurs, signe de lutte					

FONCTION CARDIO CIRCULATOIRE					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Fonctionnement / réglage du scope / gestion et réglage des alarmes					
VVP : matériel / pose / surveillance					
KTA : indication / matériel (radial, fémoral) / pose / surveillance / prélèvements artériels					
KTC : indication / matériel / montage des lignes / pose / surveillance					
KT intra-osseux : indication / matériel / pose / surveillance					
DSA : localisation / utilisation / maintenance					
Catécholamines : indications / préparation de seringue + pose / surveillance / relais sur base intelligente					
Interprétation / surveillance des tracés ECG					
Reconnaître l'ACR / pratique du MCE + 10 commandements / gestion de l'urgences vitale					
Port à cath + aiguille de huber					
Prélèvement veineux / artériels					
Utilisation des prescriptions connectées / couleur des tubes de prélèvement / pneumatique					

FONCTION DIGESTIVE					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Pose et surveillance d'une sonde nasogastrique / fixation					
Surveillance / traçabilité d'une aspiration digestive					
Alimentation orale, par sonde gastrique, par voie parentérale					
Surveillance / traçabilité du transit					
Surveillance des stomies					
Lavement évacuateur					

FONCTION URINAIRE					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Pose / surveillance d'une sonde à demeure					
Bandelettes urinaires / interprétation des résultats					
Lavages vésicaux (sondes à double courant) / quantification					
Surveillance d'un K.T Sus-pubien					
ECBU					

FONCTION NEUROLOGIQUE					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
État de conscience / Glasgow					
Surveillance des pupilles					
Indication / administration / surveillance des curares					
Mise en œuvre / surveillance du protocole sédation					
Ponction lombaire : préparation du matériel / surveillance + HGT au décours / envoie des tubes au laboratoire.					

THERMOREGULATION					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Hémocultures					
Indication / utilisation de réchauffeur					

ENDOCRINOLOGIE					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Connaissance des normes / gestion d'une hypoglycémie et d'une hyperglycémie					
Application du protocole insuline IVSE / SC					
Connaissance des normes / gestion d'une hypokaliémie et d'une hyperkaliémie					
Application du protocole hypo/hyperkaliémie					

TRANSFUSION SANGUINE					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Groupe A/B/O et dérivés sanguins					
Commande / réception / délivrance de culots et dérivés sanguins					
Contrôle ultime au lit du patient					
Conduite à tenir lors d'un incident transfusionnel					
Création d'un dossier transfusionnel / traçabilité					
Utilisation du logiciel ETRACELINE (traçabilité informatique)					
Évacuation des poches de sang utilisées (DAOM)					

SOINS DIVERS					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Calcul de doses					
Réfection des pansements (simple / complexe)					
Bilans entrées / sorties					
Utilisation / interprétation du PEAKFLOW					
Transfert d'un patient dans l'hôpital : préparation patient / préparation dossier + papiers administratifs / mouvement logiciel					
Transfert d'un patient hors structures : préparation patient / préparation dossier + papiers administratifs / mouvement logiciel					
Utilisation et respect des règles d'utilisation des casiers patients					
Préparation de l'opéré : préparation du patient / dossier					
Prise en charge de la douleur : Echelles d'évaluations (EN, EVS, EVA, ...) Titration morphine PCA					
Contention : indication / prescription / mise en œuvre / surveillance					
Participation à un exercice AMAVI (anciennement Plan Blanc)					

ENTRETIEN DU MATERIEL					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Bionettoyage d'une chambre / d'un box					
Décontamination du matériel					
Vérification d'une chambre / d'un box = Check List					
Vérification chariot d'urgence / 10 commandements					
Vérification sac à dos d'urgence					
Connaissance / rangement du lieu de stockage du matériel					
Pharmacie : commande en urgence / vérification des stupéfiants					
Utilisation des glucomètres : vérification hebdomadaire, code bandelette.					
Utilisation des cétonémies					
Utilisation des Cardiolex					
Utilisation du coupe bague électrique					
Vérification des chariots de suture					
Vérification du box plâtre					
Utilisation des blader scan					

ISOLEMENT					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Mise en place d'un isolement (BMR, BHR, ...)					
Respect des règles d'isolement					
Dépistage systématique d'un patient BMR					
Connaissance des germes multi résistants					
Prescription des dépistages / isolements					

FORMALITES ADMINISTRATIVES					
	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Lecture des résultats biologiques sur logiciel DxCare					
Rédaction d'une FEI					
Savoir ou trouver les protocoles / procédures.					
Rédaction d'une transmission ciblée dans le dossier du patient					
Prise en charge d'un patient mineur					

Rédaction d'un constat de chute					
Rédaction d'une fiche de fugue / sortie à l'insu du service					

CAPACITES D'ORGANISATION ET RESPECT DE L'ORGANISATION DU SERVICE ET DE L'HÔPITAL

	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Respect de l'organisation et du fonctionnement du service					
Capacité d'adaptation à l'urgence					
Esprit de synthèse, capacité d'analyse					
Prise en charge globale de patients ou de sa zone de soins et capacité à aider les autres membres de l'équipe					
Savoir gérer les priorités / avoir une vision globale de l'activité du service					
Respect des POS du service					
Respect des horaires de travail					
Respect des trames organisationnelle					
Respect de l'organisation et du fonctionnement du service					

CAPACITES RELATIONNELLES

	A l'arrivée	A 1 mois	A 3 mois	A 6 mois	A 1 an
Relations avec le patient					
Communication avec le patient					
Respect de la pudeur					
Prise en compte du confort / de la douleur du patient					
Respect dans la mesure du possible des croyances et valeurs du patient					
Prise de recul / gestion des émotions					
Informations sur sa prise en charge					
Relations avec les accompagnants					
Information des accompagnants					
Respect de la charte de l'accompagnant					
Accueil téléphonique (pas d'information par téléphone)					
Relations avec l'équipe / intégration					
Curiosité intellectuelle					
Capacité à se remettre en question / ouverture d'esprit / savoir s'auto-évaluer					
Capacité à prendre des initiatives					
Capacité à se positionner dans l'équipe					

Savoir gérer son stress					
Accepter d'être accompagné et doublé par l'encadrement					

Mes livrets d'accueil

Tome 1 - La fondation et l'hôpital

Tome 2 – Le service des urgences

Tome 3 – Mon intégration

Tome 4 – Mon plan de formation et le développement de mes compétences

Tome 5 – Mes outils du quotidien

Tome 6 – Les logiciels Ressources Humaines

Tome 7 – Les logiciels métiers

Tome 8 – Les procédures et protocoles du service et de l'institution

Tome 9 – Situation sanitaire exceptionnelle